

Checkliste Geriatrie

Kognition: Vergesslichkeit

- allgemeine Einschätzung
- Zeitverlauf
- Termine vergessen
- Hinweise aus der Umgebung

Mini Mental Status

- Hör- und Sehhilfe dürfen verwendet werden
- Frage max. 3x wiederholen
- Keine falsch/richtig Bewertung während des Tests
- Keine Konversation beginnen
- Interpretation: <20 P. kognitive Beeinträchtigung sehr wahrscheinlich, 20-26 P. kognitive Beeinträchtigung wahrscheinlich, >26 P. kognitive Beeinträchtigung unwahrscheinlich

Uhrentest

Anleitung

- Legen Sie dem Patienten das Blatt mit der Aufschrift „Bitte zeichnen Sie eine Uhr“ hin.
- Instruktion *Zeichnen*: „Bitte zeichnen Sie eine Uhr mit allen Zahlen und Zeigern die nötig sind und sagen Sie mir, wenn Sie fertig sind.“
- Bei Fragen wiederholen Sie nur die Testinstruktion unter Verwendung von Synonymen, wie z.B. „Zifferblatt“ statt „Uhr“ oder „Ziffern“ statt „Zahlen“, etc.
- Instruktion *Uhrzeit eintragen*: Bitte schreiben Sie nun die Uhrzeit der gezeichneten Uhr in den unteren Kasten so wie es z.B. im Zugfahrplan oder im Fernsehheft stehen würde.
- Beginnt der Patient nicht oder hat er die Aufgabe nicht verstanden, wiederholen Sie die Anleitung maximal 3x.

Interpretation

- Sind 12 Zahlen vorhanden? → 1 Punkt
- Ist die Zahl 12 oben? → 2 Punkte
- Sind 2 unterschiedliche Zeiger vorhanden? → 2 Punkte
- Stimmt gezeichnete Zeit mit Fahrplanzeit überein? → 2 Pkte.
- ≤ 5 Punkte: Kognitive Einschränkung möglich

Basale Aktivitäten des täglichen Lebens

- Transfer
- An-/Auskleiden
- Essen/Trinken
- Ausscheidung
- Tägliche Körperpflege
- Baden/ Dusche

Instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens

- Einkaufen
- Mahlzeiten
- Haushalt
- Finanzen

Motilität

- Hilfsmittel
- Mobilität in Wohnung
- Treppensteigen
- Mobilität ausser Haus
- Stürze
- Angst vor Stürzen

Einbeinstandtest

Ausführung des Tests

- Versuchen Sie niemals, diesen Test bei Patienten durchzuführen, die nicht selbständig stehen können.
- Führen Sie den folgenden Test in der angegebenen Reihenfolge während ca. 5 Sekunden (langsam und leise bis auf 5 zählen) durch.
- Achten Sie darauf, dass der Patient die ganze Anweisung genau verstanden hat, bevor er sie ausführt.
- Geben Sie folgende Instruktion: „Stehen Sie aufrecht da mit beiden Füßen nahe beieinander. Fixieren Sie einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand. Stehen sie nun auf einem Bein, solange Sie können, ohne sich festzuhalten! Sie können auswählen, auf welchem Bein Sie stehen wollen.“
- Der Untersucher zählt langsam auf 5.
- _Der Test wird abgebrochen, wenn
- (1) der Patient mit dem hochgehobenen Fuss den Boden berührt
- (2) der Patient das Standbein zur Balancierung bewegt.

Dokumentation des Tests

- Einbeinstand Möglich (> 5 Sekunden) < 5 Sekunden oder nicht möglich

Interpretation

- Falls der Einbeinstand < 5 sec. oder nicht möglich ist, besteht der Hinweis auf eine Balancestörung.

(timed) Get up and go Test

- Benötigtes Material: Stuhl (Sitzhöhe circa 46 cm), freie Strecke von mindestens drei Metern, Markierung.
- Handlungsanweisungen: „Bitte stehen Sie auf, wenn möglich ohne dass Sie sich mit den Armen abstützen.“
- Danach gehen Sie bitte bis zur markierten Stelle, drehen sich um, kehren zum Stuhl zurück und setzen sich wieder!“
- Wichtig ist, dass der Patient während der Untersuchung nicht stürzt. Begleiten und sichern Sie den Patienten deshalb während der Testung falls notwendig.
- Sicherung des Patienten: Sichern Sie den Patienten, indem Sie mit beiden Händen sein Becken berühren und während der Testung neben ihm hergehen.
- Führen Sie den Get up & go Test wenn nötig zweimal durch, um das Gangbild besser beurteilen zu können.

Kriterien/ Interpretation

- Aufstehen
- Hilfe beim Gehen
- Beginn des Ganges
- Schrittlänge rechts/ links
- Schritthöhe rechts/ links

- Schrittbreite
- Schrittkontinuität
- Wegabweichung
- Rumpf und Arme
- 10 bis 19 Sekunden leichte Einschränkung wahrscheinlich
- 20 bis 29 Sekunden mittelgradige Einschränkung, weitere Abklärung Gang und Gleichgewicht erforderlich
- ≥ 30 Sekunden oder nicht möglich deutliche Einschränkung

Sozialanamnese

- Wohnsituation
- Beziehungsnetz
- Erhaltene Hilfe
- Soziale Aktivitäten
- Autofahren

Ernährung

- Appetit
- Gewichtsabnahme
- Aktuelle Ernährung
- Mundbereich
- Schluckstörungen
- Soziale Umstände

Funktionelles Assessment: Oraler Trakt

Spezielle Anleitungen

- Begutachtung mit getragenen Zahnersatz, damit ein Überblick über die Funktion gewonnen werden kann:
 - linke Kauseite, rechte Kauseite begutachten
 - defekte Rekonstruktionen notieren
- Zahnersatz entfernen lassen
- Patienten anweisen, den Mund zu öffnen und den Kopf etwas nach hinten zu lehnen
- Mundschleimhaut begutachten. Dabei mit Finger der einen Hand die Lippen hochziehen und mit der Taschenlampe in der anderen Hand die Mundschleimhaut beleuchten.
- Systematisch die Mundschleimhaut untersuchen (Befunde gemäss untenstehendem Schema notieren):
 - Lippeninnenseite: Oberlippe dann Unterlippe
 - Gaumen
 - Alveolarkämme
 - Zunge
 - Mundboden
- PAParQuadrantenweise Gingiva beurteilen auf Schwellung, Rötung und evtl. Taschenbildung
- Quadrantenweise Zähne auf Frakturen und Kavitäten beurteilen
- Quadrantenweise Mundhygiene beurteilen

Beurteilung Ober-/Unterkiefer

- Anzahl eigene Zähne
- Anzahl Zähne mit Karies
- Gelockerte Zähne
- Prothese

- Prothesendruckstellen

Beurteilung Mundhöhle

- Paradontitis
- Mundtrockenheit
- Hinweise für Neoplasie

Urininkontinenz

- Urininkontinenz
- Hilfsmittel (Einlagen, Katheter)

Medikamentenanamnese

- Medikamente
- Stärkungsmittel, Vitamine, Homoeopathische Präparate etc
- Hilfsmittel (Karte, Dosett)

Visus

- Allgemeine Einschätzung
- Hilfsmittel
- Spezielle Umstände (Zeitung, Gesichter, Autofahren bei Nacht)
- Auswirkungen im Alltag

Visus-Test (Jäger-Test)

Vorgehen

- Patient deckt linkes Auge mit einem Zettel ab.
- Patient soll jede Zahl lesen auf der Linie mit den kleinsten Zahlen, die er noch lesen kann. Linie notieren, auf welcher der Patient alle Zahlen richtig lesen kann.
- Test beim rechten Auge identisch wiederholen.
- Falls Patient grösste Zahl nicht lesen kann, dann
 - Finger zählen (50cm, falls möglich 1m)
 - Hand bewegen (50cm, falls möglich 1m)
 - Licht wahrnehmen (Lichtperzeption ja/nein)
- Beschreibung des Nahvisus für jedes Auge (Angabe falls mit Hilfsmittel).

Interpretation

- Ist-Entfernung/Soll-Entfernung kann in Visus umgerechnet werden: 20/20 entspricht 1.0 (ca. 100%), 20/40 entspricht 0.5 (ca. 50%), 20/400 entspricht 0.05 (ca. 5%).
- Ein Visus von ≤ 0.5 gilt als Sehbeeinträchtigung.

Gehör

- Allgemein Einschätzung
- Hilfsmittel
- Spezielle Umstände (Gespräche mit einer/ mehreren Personen)
Einschränkungen im Alltag

Gehör-Test (Whisper-Test)

- Patient soll allfällige Hörhilfe tragen (Ziel: Messen des Gehörs mit bestmöglicher Korrektur, allenfalls Funktionskontrolle der Hörhilfe). Ruhige Umgebung, gegebenenfalls Fenster schliessen.

Vorgehen:

- Der Untersucher befindet sich ausserhalb des Gesichtsfeldes hinter dem Patienten.
- Der Untersucher vertäubt das abgewandte Ohr (Reiben auf Tragus).
- Drei zweistellige Zahlen (z.B. 33, 44, 55, etc.) mit Restluft flüstern in Distanz von ca. 60cm. Falls >1 Zahl nicht gehört wird, wiederholen Flüstern in Ohrnähe, Umgangssprache 60cm, Ohrnähe.
- Testung beim anderen Ohr wiederholen.

Interpretation

- Beschreibung der Hörfähigkeit für jedes Ohr (Angabe falls mit Hilfsmittel).
- Ein Hinweis für eine Hörstörung besteht, wenn pro Seite von den 3 Flüsterzahlen in 60 cm > 1 Zahl nicht gehört werden.

Ergänzung:

- Flüstersprache 6m verstanden: Hörschwelle normal
- Flüstersprache 60cm verstanden: Hörschwelle 0 bis 40 dB erhöht
- Flüstersprache Ohrnähe verstanden: ca. 50 dB erhöht
- Umgangssprache 60cm: ca. 60 dB erhöht
- Umgangssprache 10cm: ca. 70 dB erhöht
- Schreien Ohrnähe: ca. 90 dB erhöht